

Cetoacidose diabética · pilares

CAD = hiperglicemia + acidose metabólica com ânion gap + cetonemia/cetonúria. Trate volume e K z com o mesmo rigor da insulina.

Critérios usuais

Dica - Critérios usuais

Glicemia tipicamente > 250 mg/dL, pH < 7,3 ou $\text{HCO}_3^- < 18$, cetonas positivas. Em uso de SGLT2, lembre euglicemic DKA (glicemia pode não estar muito alta).

Use o ânion gap para acompanhar a resolução da cetoacidose; reponha K z antes de 'acelerar' insulina se hipocalemia.

Anion gap e pilares da CAD

Na - (Cl + HCO_3^-) e sequencia terapeutica

$$\text{AG} = \text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3^-)$$

AG alto + cetonas + glicemia alta = CAD ate prova em contrario

Conduta em 4 passos

- Volume: SF 0,9% inicial; depois ajustar conforme Na corrigido e diurese
- Potássio: se K z < 3,3 mEq/L, repor antes de insulina; se 3,3–5,2, repor junto
- Insulina: infusão EV contínua (ex.: 0,1 U/kg/h) após K z seguro
- Glicose: quando glicemia ~200–250, associar SG para continuar insulina até fechar gap

Resolução — o que observar

Parâmetro | Alvo prático

Ânion gap | Normalização (melhor marcador da cetose)

HCO_3^- / pH | Melhora sustentada

Cetonas | Em queda

Transição SC | Quando comer e gap fechado / clinicamente estável

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Insulina 'empurra' K z para dentro da célula. Iniciar insulina com hipocalemia grave pode precipitar arritmia — reponha K z primeiro.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Critérios laboratoriais da CAD, ânion gap e reposição de volume/K/insulina são clássicos de prova.

Hiperglicemia + acidose metabólica com gap !' + cetonemia/cetonúria.

Critérios laboratoriais CAD

Triade clássica

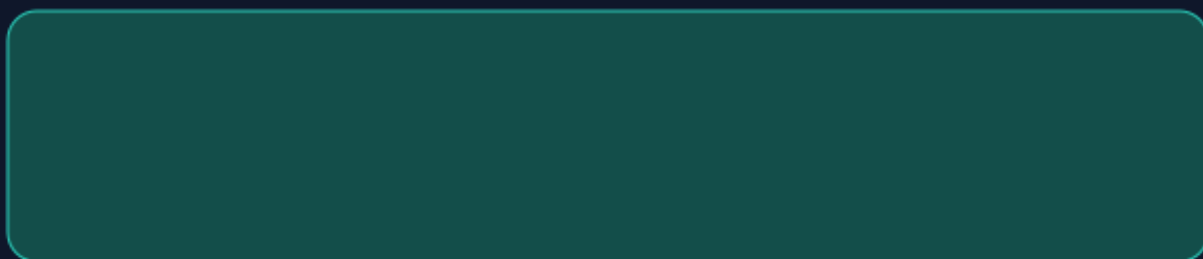
- 1 Glicose tipicamente > 250 mg/dL
- 2 pH < 7,3 ou $\text{HCO}_3^- < 18$
- 3 Cetona positiva (sangue/urina)
- 4 Anion gap elevado

Variantes: euglicêmica (SGLT2) — cetoacidose com glicose perto do normal

Gap e déficit de água guiam interpretação e reposição.

Anion gap e água

Formulas de prova



Severidade da CAD (ideia ADA)

Parâmetro | Leve | Grave

pH | 7,25–7,30 | < 7,00

HCO_3^- | 15–18 | < 10

Ânion gap | > 10 | > 12

Sensorium | alerta | estupor/coma

Tratamento em 4 pilares

- Volume: SF 0,9% inicial (ex. 1 L/h na 1ª hora se choque/desidratação grave, depois ajustar)
- Insulina: bolo ± infusão contínua (ex. 0,1 U/kg/h) até fechamento do gap / resolução da cetose
- Potássio: se $\text{K} < 3,3$!' repor antes de insulina; se 3,3–5,2 !' repor com insulina
- Tratar precipitante: infecção, IAM, omissão de insulina, SGLT2, gestação

Quando adicionar glicose

Atenção - Quando adicionar glicose

Quando glicemia ~200–250 mg/dL, trocar para SG (D5) + insulina para continuar fechando o gap sem hipoglicemia.

CAD vs EHH

Dica - CAD vs EHH

EHH: glicose muito alta (>600), osmolaridade $!!$, pH e HCO_3 relativamente preservados, cetose mínima/ausente, mais comum no idoso tipo 2.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1